

KC桌面——外资精译

UBS：医疗保健设施与管理式医疗医疗保健视野首批婴儿潮一代今年年满80岁

通过这份研究报告，我们推出一份名为“医疗保健视野”的新主题报告。我们计划利用这些报告来审视医疗保健服务中更广泛的演变主题。本首期报告探讨了首批婴儿潮一代于2026年年满80岁的影响。

婴儿潮一代人口结构将在未来15年推动“80岁以上”年龄组增长

2026年代表着一个关键的人口结构里程碑，因为婴儿潮一代（出生于1946年至1964年）的首批成员将达到80岁。尽管人口老龄化一直是一个长期趋势，但众多人口结构分析强调，一旦个人进入80多岁，其健康状况、医疗资源利用和支出都会发生显著变化，这使得该阶段与更广泛的65岁以上人口群体截然不同。布鲁金斯学会的研究预测，美国80岁及以上人口将在2020年代中期至2040年代中期大约翻一番，从约1500万人增至近3000万人。美国人口普查局的数据同样显示，老年人口群体的增长速度预计将快于较年轻年龄群体。更具体地说，人口普查局预计，85岁及以上的成年人到2040年将达到约1400万，较2022年约600万的85岁以上成年人数量增长72%。从医疗保健服务的角度来看，这一转变意义重大，不仅因为人口扩张，还因为80岁以后的医疗需求、护理时长以及对支持服务的依赖程度显著增加，从而改变了医疗保健需求的构成和规模。

医疗保健支出随年龄增长显著增加

国民健康支出数据显示，医疗保健成本随年龄增长显著增加，并在最年长的年龄群体中进一步攀升。例如，2020年，65岁及以上老年人的人均个人医疗保健支出为22,356美元，是儿童支出水平的五倍多，约为劳动年龄成年人的2.5倍。尽管该年龄组仅占总人口的17%，但在2020年却占医疗保健总支出的约37%。美国医疗保险和医疗补助服务中心的数据还显示，85岁及以上成年人的人均医疗保健支出更高，平均约为36,000美元，超过了较年轻老年人的支出水平。这些数据强调了这样一种观点：人口结构向老龄化转变，特别是80岁及以上人群，为医疗保健支出创造了结构性顺风，预计这一趋势未来将进一步加速。

然而，医疗保健利用的类型随年龄增长而变化，尤其是在80岁以上阶段

随着人口从65岁向80岁以上老龄化，医疗保健利用从预防性和选择性服务显著转向更复杂的慢性病管理和更高acuity的护理，这是由于多病共存情况增加以及跨场景的护理协调需求增大所驱动。虽然较年轻的老年人（65-74岁）仍处于“维持阶段”，支出集中在门诊、医生和药物使用上，但75-84岁年龄组的住院、专科医生密集度和急性后期护理使用显著增加。这一趋势在85岁以上人群中进一步加速，其支出日益倾向于基于时长的服务，如专业护理、居家保健、临终关怀以及长期服务和支持。在此背景下，老龄化人口——其医疗消费已是普通人群的数倍——应继续推动整个系统的增量需求，即使医疗服务提供方式发生结构性转变。同时，对“就地养老”日益增长的偏好（大多数老年人偏爱居家护理）强化了居家保健和社区服务的长期顺风，这受到成本考量、社会因素以及改善的居家护理能力的支持。

专业护理机构、居家保健、住院康复、临终关怀、辅助生活、殡仪馆将迎来积极转折点

我们预计急性后期护理场景将成为80岁以上人口增长的主要受益者。这包括住院康复机构、居家保健、临终关怀和专业护理机构等场景，我们预计这些场景将因该人口群体的增长而获得业务量上的好处，因为这些场景主要服务于老年患者群体。转向低成本护理场景的业务量也应受益于管理式医疗组织和支付方日益寻求控制成本，因此可能会引导患者前往这些低成本场景，如居家保健和专业护理机构。因此，我们认为居家保健、住院康复和专业护理运营商是这一人口结构趋势的明确赢家。辅助生活、临终关怀、个人护理和殡仪馆等领域也可能受益。因此，我们重点列出了七家我们认为可能在未来十年受益于婴儿潮一代老龄化的公司：Addus HomeCare Corporation (ADUS)、BrightSpring Health Services (BTSG)、Encompass Health (EHC)、Ensign Group

(ENSG)、Health Care Services Group (HCSG)、PACS Group (PACS) 和 Service Corporation (SCI)。未覆盖的、与此主题相关的公司包括 Brookdale Senior Living (BKD)、Chemed (CHE) 和 Pennant Group (PNTG)。

UBS HOLT 视角提供进一步洞察

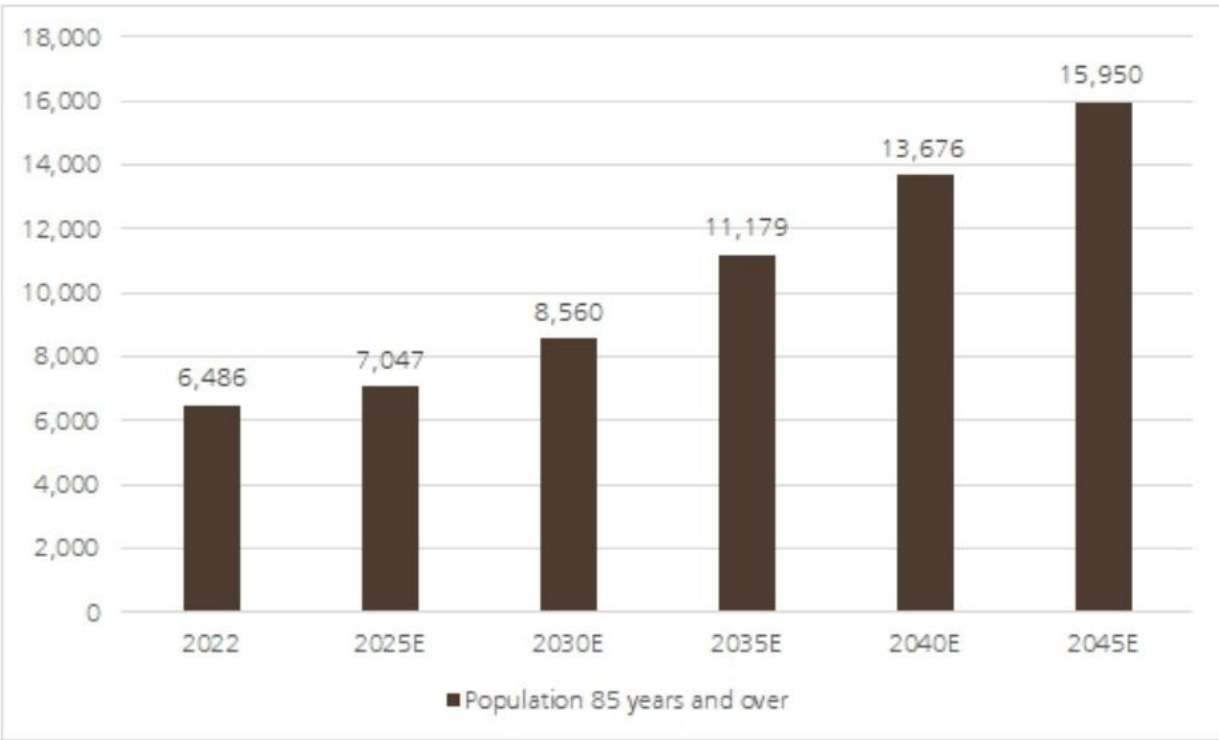
在本报告中，我们还利用 UBS HOLT 框架来补充我们的分析。UBS HOLT 是一个客观的、基于现金流的框架，用于评估公司业绩和估值，独立于我们的基本面分析。根据 HOLT 评分卡，该组公司整体表现良好，十家公司中有八家在 HOLT 宇宙中排名前一半。运营质量是最强因素，五家公司处于前五分之一（ADUS、BTSG、CHE、EHC 和 SCI），这得益于它们高且稳定的现金流回报表现率。

评估人口老龄化的影响

美国人口正在老龄化

2026年将成为一个人口结构转折点，首批婴儿潮一代（1946 – 1964年出生）届时将年满80岁。尽管人口老龄化一直是持续趋势，但多项人口分析强调，当个体进入80岁后，其健康状况、医疗使用和支出会发生显著变化，这使得该阶段与更广泛的65岁以上人群截然不同。布鲁金斯学会研究预测，美国80岁及以上人口将在2020年代中期至2040年代中期大约翻倍，从约1500万人增至近3000万人。美国人口普查局数据同样显示，老年人口群体的增长速度预计将快于年轻年龄群体。更具体而言，人口普查局预计，85岁及以上成年人口到2040年将达到约1400万，较2022年约600万增长72%。从医疗服务角度看，这一转变之所以重要，不仅是因为人口增长，更因为80岁之后，护理需求、护理时长以及对支持服务的依赖会不成比例地增加，从而改变医疗需求的构成和强度。

图1：美国85岁及以上成年人口（单位：千人）

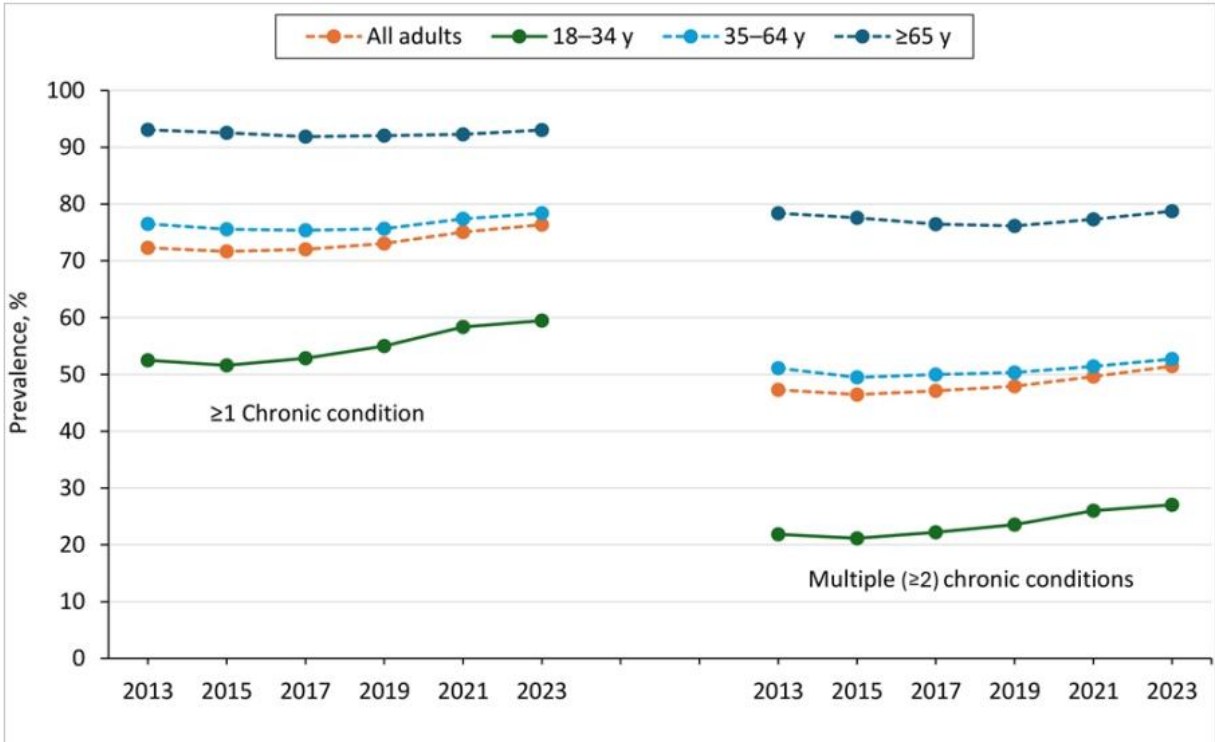


图表 1

资料来源：人口普查局和UBS；人口单位：千人

美国人口中慢性病患病率预计也将上升。根据Frontier Health数据，到2050年，50岁及以上至少患有一种慢性病的人数预计将增长99.5%（从2020年的约7200万增至约1.43亿），而患多种疾病的人数预计到2050年将增长略超90%，达到1500万。美国疾病控制与预防中心的数据发现，每10名美国老年人中就有9人报告患有一种或多种慢性病，而约79%的老年人患有多种慢性病。

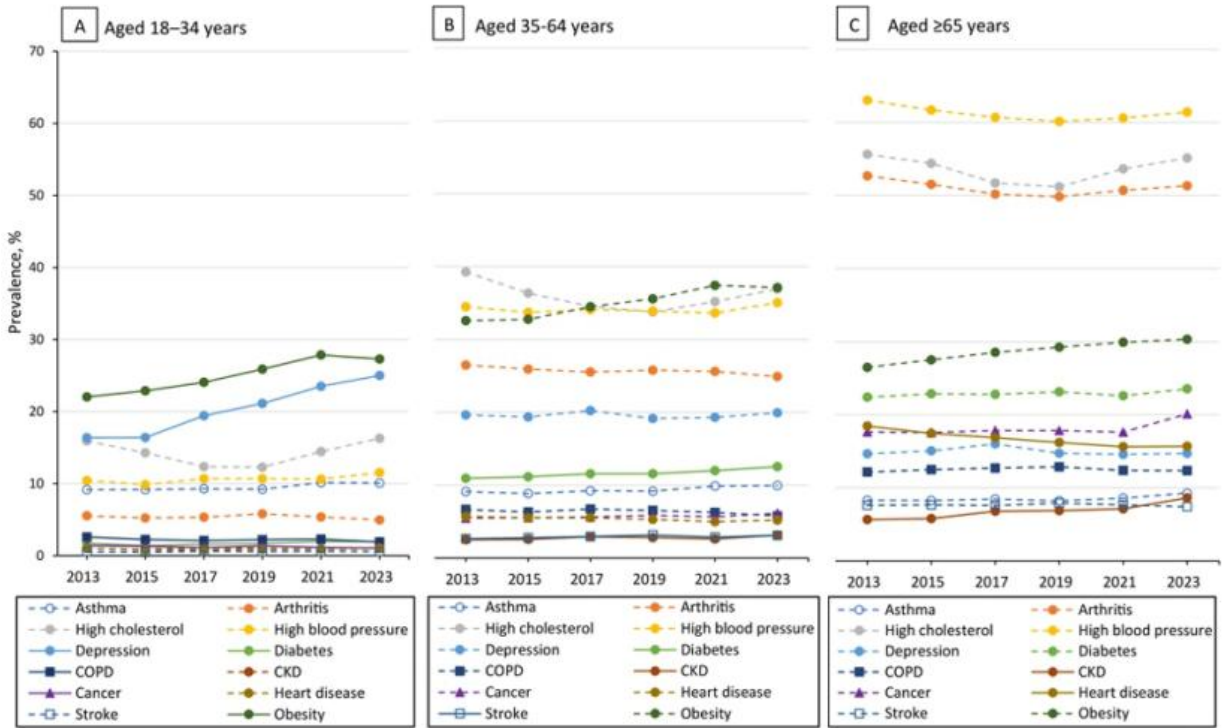
图2：慢性病患者率随年龄增长而上升



图表 2

资料来源：美国疾病控制与预防中心

图3：慢性病趋势

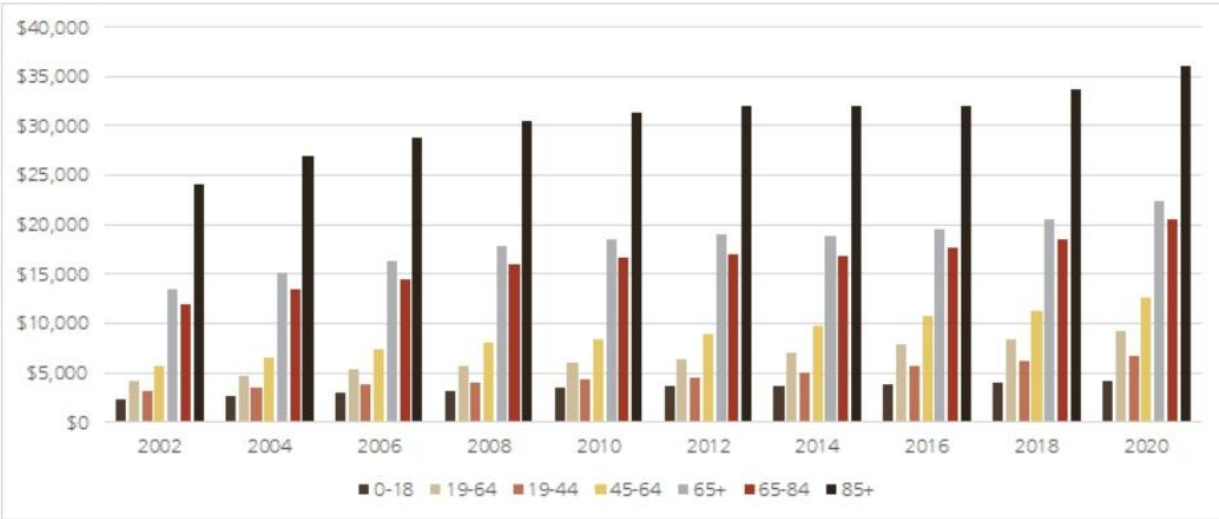


图表 3

资料来源：美国疾病控制与预防中心

高龄阶段支出急剧上升

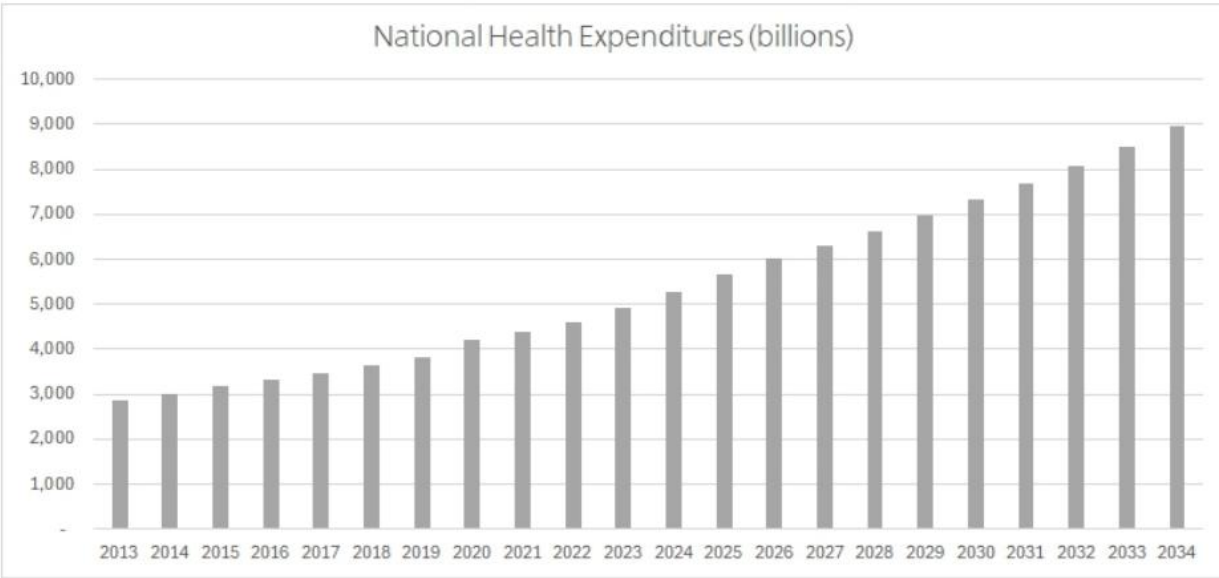
图4：按年龄组划分的人均个人医疗保健总支出



图表 4

资料来源：人口普查局和UBS

图5：美国医疗保健支出预测



图表 5

资料来源：CMS

老年人医疗利用随年龄增长而变化

随着老年人从65岁过渡到80岁，医疗利用从预防保健和择期手术显著转向慢性病的强化管理和更高 acuity 的治疗。这反映了多病共患负担的加重，既增加了就诊频率也提高了护理复杂性，从而推动了初级、专科和协同护理领域的更高利用率。行业评论强调，老年群体需要越来越多的慢性病管理和更高强度的干预，而这一动态因65岁以上人群的医疗服务利用率已是普通人群的数倍而被放大。因此，人口老龄化只会增加美国对医疗资源和服务的需求。与此同时，在老龄化曲线的早期阶段，护理提供持续向门诊和日间手术环境迁移，这既反映了临床偏好，也体现了在低 acuity 环境下改善的疗效。

重要的是，随年龄增长而增加的支出并非纯粹是数量故事，而是反映了所提供护理组合的根本性转变。在65 – 74岁群体中，支出仍以门诊、医生和药物使用为主，这与慢性病管理的“维持阶段”相符，对机构护理的依赖有限。到75 – 84岁，多病共患的增加推动了住院入院率和专科强度的提升，同时随着更多患者出院接受康复和专业护理，急性后期服务的作用日益增强。最显著的变化发生在85岁以上群体，其支出越来越集中于急性后期和支持性护理类别，包括专业护理机构、家庭保健和临终关怀。在此阶段，成本增长更多由基于时长的使用驱动，而非离散的临床干预，包括专业护理机构天数、家庭保健疗程、临终关怀以及长期服务和支持。

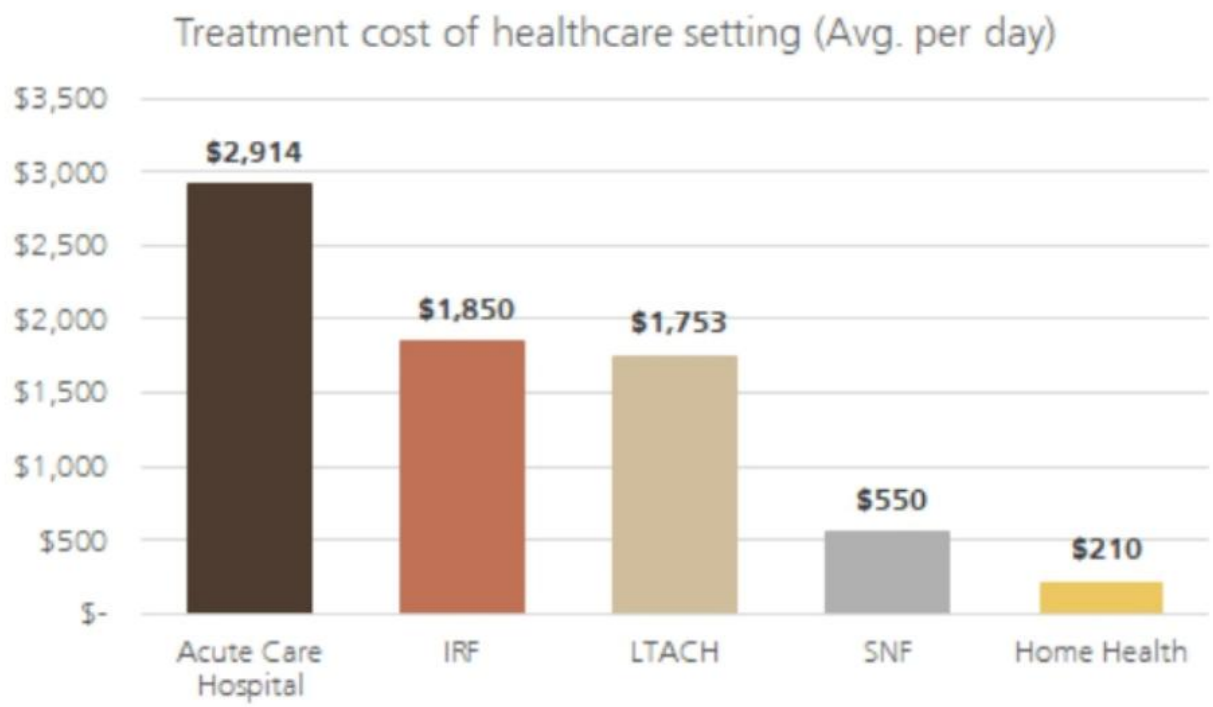
对医疗服务的影响

护理场所转移使急性后期环境受益

我们预计急性后期环境将成为人口老龄化的主要受益者。这包括住院康复机构、家庭保健、临终关怀和专业护理机构等环境，我们预计这些环境将从人口老龄化中获得数量增长，因为它们主要服务于老年患者群体。向低成本护理场所的转移也应受益于管理式医疗组织和支付方日益寻求控制成本，因此很可能将患者引导至这些低成本环境。

家庭保健被视为最大受益者之一：随着管理式医疗组织和州/联邦资助机构寻求优化治疗和成本效率，基于家庭的护理因其较低成本而成为受益者。如下所示，家庭保健的成本比最昂贵的治疗方案便宜多达13倍。此外，研究表明，家庭护理的好处不仅限于财务方面。事实上，根据美国国家医学图书馆发表的一项研究，家庭护理已被证明成本更低，且重要的是，与医院护理相比，再入院率更低（见此处）。此外，美国国家医学图书馆估计，与患者出院后30天内再入院相关的年度可避免成本约为410亿美元。另外，《美国管理式医疗杂志》发表的一项研究发现，接受家庭保健的患者再入院不确定性降低了60%。

图6：按护理场所划分的每日治疗成本



图表 6

资料来源：公司报告和Genworth护理成本调查

图7：Medicare按服务收费的急性后期出院份额



图表 7

资料来源：MedPac数据手册

与传统的住院治疗相比，急性医院家庭护理疗程在超过一半的前25个Medicare严重程度诊断相关分组中，也与出院后30天内较低的Medicare支出相关。所有这些都支持了家庭护理对于支付方、患者和提供者的成本效益和日益增长的吸引力。因此，麦肯锡估计，目前在为按服务收费和Medicare Advantage受益人提供的传统机构中交付的、价值高达2650亿美元的护理服务可能会转移到家庭，这并不令人意外。

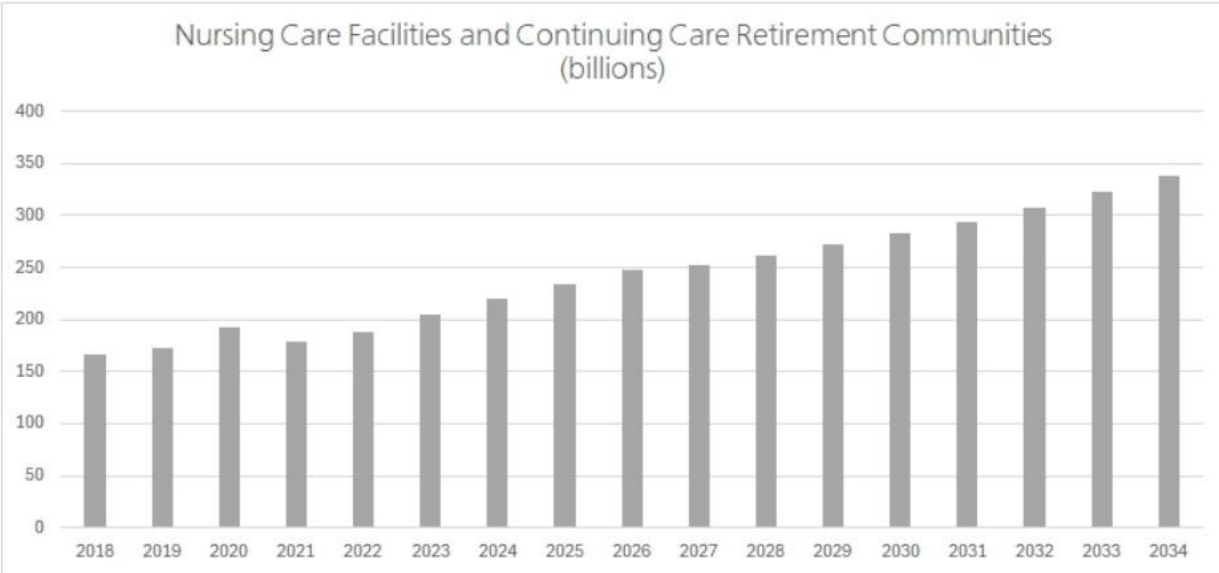
美国人口不仅正在老龄化，而且老年人越来越倾向于留在家中接受照护，即所谓的“就地养老”。美国退休人员协会（AARP）最新的《家庭与社区偏好调查》显示，绝大多数老年人（60岁以上）希望留在自己家中（75%）和社区（73%）。这种重新燃起的就地养老愿望的原因包括但不限于：生活成本、维持现有的社会和家庭联系、对新型辅助技术（门铃、摄像头、智能家居设备等）的信心。虽然许多人（44%）认为离开家去机构养老是不可避免的（主要出于健康担忧），但居家健康和养老需求的日益增长，为家庭健康护理机构带来了又一利好。

个人护理服务：虽然许多老年人在65岁时仍很活跃，但到80岁时，对日常生活活动（ADL）帮助的需求会显著增加。根据Addus的数据，大约90%的65岁及以上成年人希望尽可能长时间地“就地养老”。个人护理服务能够满足这一需求，通过提供非医疗性的帮助，如洗澡、穿衣、备餐和家务，这些对于住院或入住机构不确定性较高的老年人至关重要。对ADL帮助的需求随年龄增长而增加，随着高龄老年人数量的增加，对ADL帮助服务的需求只会增长。根据2018年的一项研究，大约20%的85岁及以上成年人需要ADL帮助，这一比例是75-84岁年龄段（8.7%）的两倍多，而65-74岁年龄段的这一比例为3.7%。

专业护理机构：另一个低成本护理场所选择

与家庭健康类似，我们认为专业护理机构（SNF）是人口老龄化趋势的主要受益者之一。ENSG等行业运营商认为，这将是一个长达十年的利好因素，目前仅处于早期阶段。虽然不如家庭健康便宜，但SNF确实为支付方提供了一个低成本的护理场所，每天仅需550美元。此外，那些表现出高评分质量的顶级运营商也能为其患者带来良好的治疗效果，并将继续成为转诊管理者首选的出院护理场所。

图8：护理机构和持续护理退休社区的NHE支出预测（百万美元）



图表 8

来源：CMS

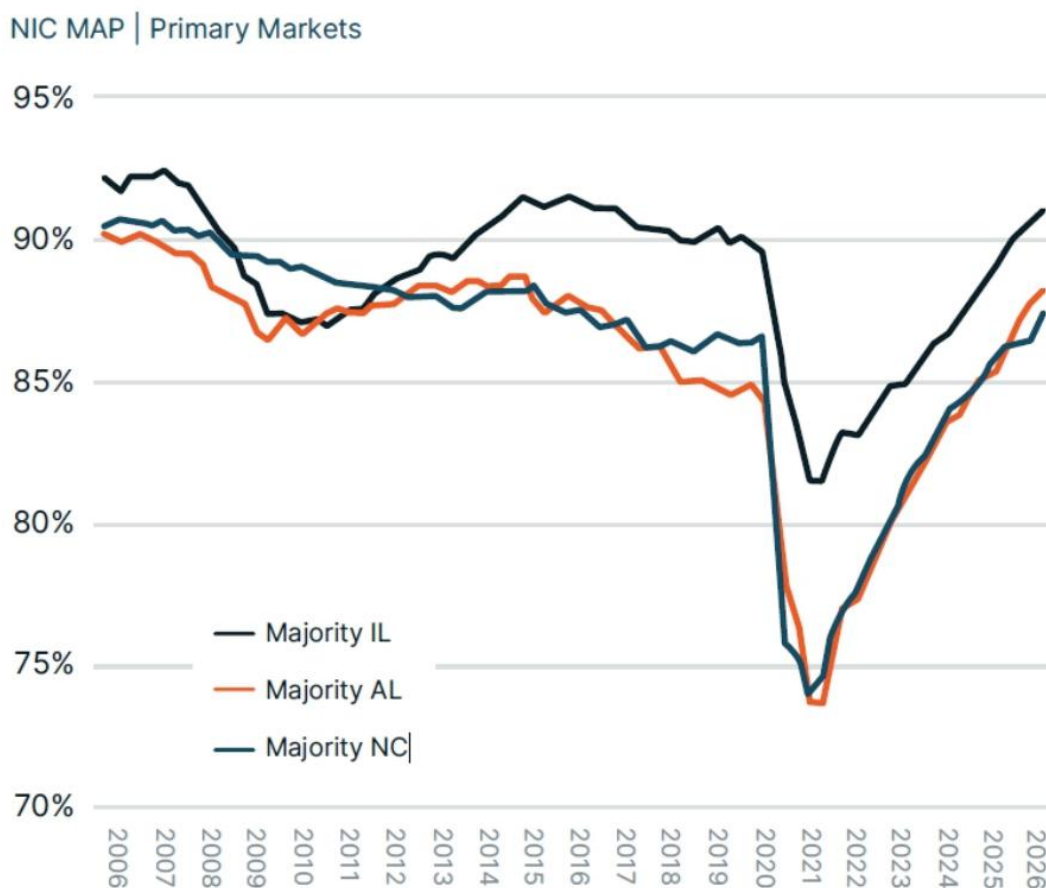
临终关怀服务量也应受益于人口老龄化

临终关怀服务量受益于人口老龄化带来的显著结构性支撑，因为对临终关怀的需求与年龄密切相关，并在75岁以上年龄组中不成比例地增加。随着预期寿命的延长，更大比例的人口进入高龄阶段，慢性进行性疾病（如癌症、痴呆症和心血管疾病）的患病率随之上升，从而扩大了符合临终关怀服务条件的患者群体。根据Caring Hospice Institute的数据，临终关怀入院时的平均年龄约为80岁，最大的单一年龄段是85岁及以上。从服务量角度看，老年人口的增长不仅增加了死亡总人数，还延长了死亡前功能调整的持续时间，支持更早的转诊和更长的住院时间，共同推动了总患者住院天数。此外，意识的提高、医生转诊实践的演变以及医疗保险的支持，促使临终关怀利用率稳步上升，表明人口扩张正伴随着渗透率的长期增长。根据National Alliance for Care at Home的数据，2024日历年，有190万医疗保险受益人在临终关怀机构注册了一天或更长时间，比2023日历年增长了4.4%。此外，在2024日历年所有医疗保险死亡者中，53.1%的人至少接受了一天的临终关怀，并在死亡时已注册临终关怀，这标志着连续第三年的改善。

老年住宅和辅助生活：需求上升，供应受限

老年住宅数据同样反映了与人口老龄化同步增长的需求。美国老年人住房与护理研究中心（NIC）报告称，2025年美国老年住宅入住率约为88-89%，标志着入住率连续四个季度以上实现季度增长。截至2026年第一季度的数据显示，入住率为89.5%，环比上升40个基点。NIC指出，需求增强是由婴儿潮一代人口老龄化推动的，而新库存供应有限，2025年第四季度库存增长率低于1%，并且是连续第三个季度库存增长率低于1%。NIC预测，到2026年底，老年住宅入住率可能超过90%，尤其是在独立生活和辅助生活类别中，因为需求持续超过新建速度。鉴于美国预期的人口趋势，我们认为老年住宅和辅助生活的需求只会从现在开始增长。

图9：按物业类型划分的入住率



图表 9

来源：NIC MAP：IL - 独立生活；AL - 辅助生活；NC - 护理

殡葬服务量也将受益于人口老龄化

婴儿潮一代步入高龄阶段，也对殡葬服务行业（包括殡仪馆、墓地和火葬服务商）产生影响。死亡率随年龄增长而急剧上升，尤其是80岁以后，这使得这一人口结构里程碑成为长期推动业务量的积极因素。事实上，美国最大的殡葬和墓地运营商之一SCI指出，我们目前仅处于婴儿潮一代老龄化带来的预期十年顺风的初期阶段。美国疾病控制与预防中心（CDC）和社会安全管理局（Social Security Administration）的生命表显示，尽管高龄人群的预期寿命有所改善，但年度死亡概率在高龄群体中呈指数级增长。全美殡葬业者协会（NFDA）预测，死亡人数将持续上升至2045年，预计到2045年将比2022年增加19%。尽管如此，消费者偏好的持续转变在一定程度上缓和了收入增长。NFDA预计火化率将大幅上升，从2025年的约63%增至2045年的82.3%，而土葬率预计到2045年将降至13.3%。火化服务的平均每单收入通常低于传统土葬，这给即时殡葬收入带来了结构性不确定性，尽管业务量在上升。NFDA指出，家庭对火化的偏好增加受到成本考量、环境担忧、宗教禁忌减少以及追求更简单葬礼仪式的影响，同时无宗教信仰人数的增加也导致了传统葬礼的减少和火化的兴起。墓地运营商和预售业务预计也将从人口老龄化中受益。预售销售额随年龄增长而增加，因为进入70多岁和80多岁的人更有可能预先安排葬礼和墓地服务。这些合同会产生递延但相对可预测的未来收入流。

医院：公司情况更新

有趣的是，随着老年人年龄增长，医院住院量并未出现明显的利用率下降。根据医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）关于Medicare按服务收费医院住院的数据，65-74岁年龄组的每1000名Medicare A部分参保人出院人数最低，为147人次，随后75-84岁年龄组增至275人次，85-94岁年龄组再次增至461人次。

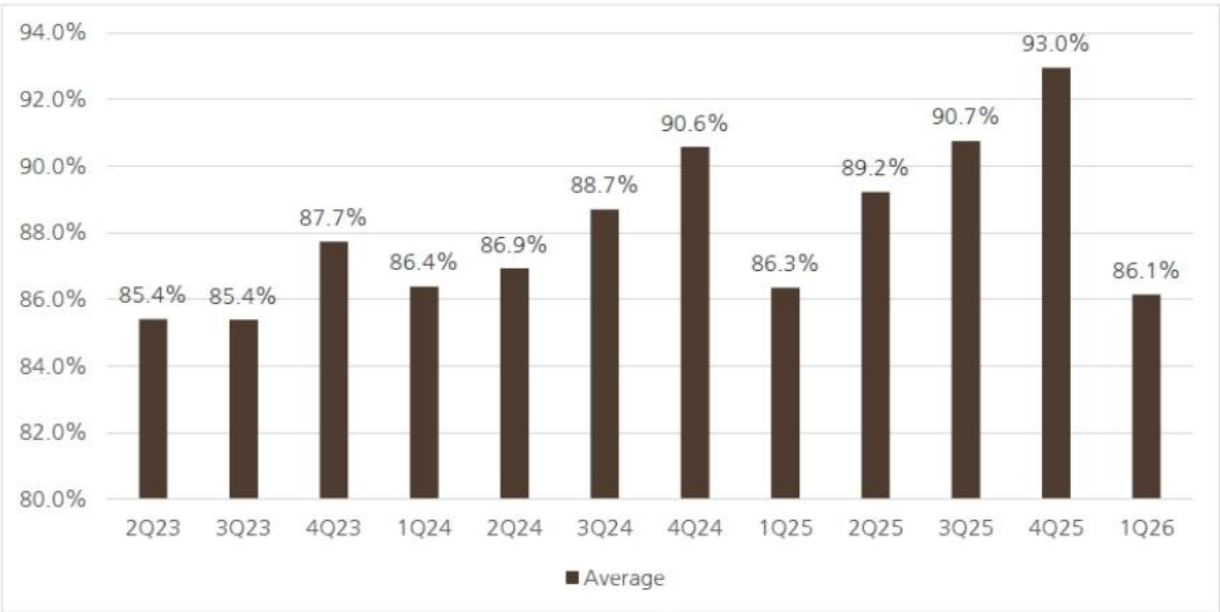
图10：按年龄组分列的Medicare按服务收费住院医院利用率趋势

来源：CMS和UBS

管理式医疗组织（MCO）可能面临老年成员利用率上升的不确定性，但预计MCO将引导成员转向低成本环境

美国人口老龄化已经有利于管理式医疗组织（MCO）的Medicare Advantage（MA）成员总数，这反过来又帮助增加了保费。随着MA成员年龄的增长，理论上由于老年人慢性病患率增加，成员遭遇额外医疗事件的次数增多，利用率可能会上升。然而，重要的是要认识到，疾病负担较重的成员通常不确定性评分更高，因此CMS向MCO支付的用于照顾这些病情较重患者的费用也更高。就不确定性模型和年龄组而言，CMS-HCC模型系数会根据年龄自然递增。然而，年龄分组是按4年递增的（75-79、80-84、85-89等）。因此，假设一个成员的HCC代码不变，但年龄进入下一个年龄段，在其他条件不变的情况下，这将为收入带来顺风。话虽如此，如果成员的健康状况在80岁后迅速出现变化，MCO将无法在次年之前捕获这些代码。这反过来会导致收入水平降低和医疗费用支出增加，直到成员的不确定性评分被适当捕获和评分。我们认为MCO将寻求通过更多地利用基于价值的护理合同以及引导成员转向低成本护理场所（如家庭健康）等方式，更好地管理这一老龄化人口群体。

图11：MCO的医疗损失率（MLR）趋势



图表 10

来源：公司报告；不包括ALHC

劳动力与护理人员短缺成为制约因素

尽管人口趋势表明需求上升，但业务量的增长受到劳动力可用性的制约。根据两党政策中心（Bipartisan Policy Center）的数据，美国在过去20多年里一直面临直接护理人员的持续短缺，预计2022年至2032年间将有近900万个直接护理职位空缺。报告强调，人员短缺迫使许多家庭健康服务提供商拒绝转诊患者，并导致医院出院延迟。与此同时，无偿护理已成为护理系统的重要组成部分。美国退休人员协会（AARP）和全美护理联盟（National Alliance for Caregiving）2025年的报告估计，有6300万美国人提供了无偿护理，自2015年以来增长了近50%。此外，社区生活管理局（Administration for Community Living）观察到，直接护理专业人员的有限可用性限制了老年人和残疾人获得社区服务的机会。这些趋势表明，鉴于美国人口老龄化，护理需求与满足这一需求的有限护理人员供应之间日益失衡。

利用UBSHOLT框架构建关于我们“80岁以上受益者”的讨论

在本节中，我们利用UBSHOLT框架为本报告中重点介绍的公司提供更多见解。UBSHOLT是一个客观的、基于现金流的框架，用于评估公司业绩和估值，独立于我们的工作。其核心是，HOLT使用其专有的现金流回报表现率（CFROI）方法衡量投入资本回报率，该方法在不同地区和行业一致应用。该框架还通过模拟公司现金流生成随时间推移的可持续性和衰减来评估估值。

HOLT评分卡与因子分析

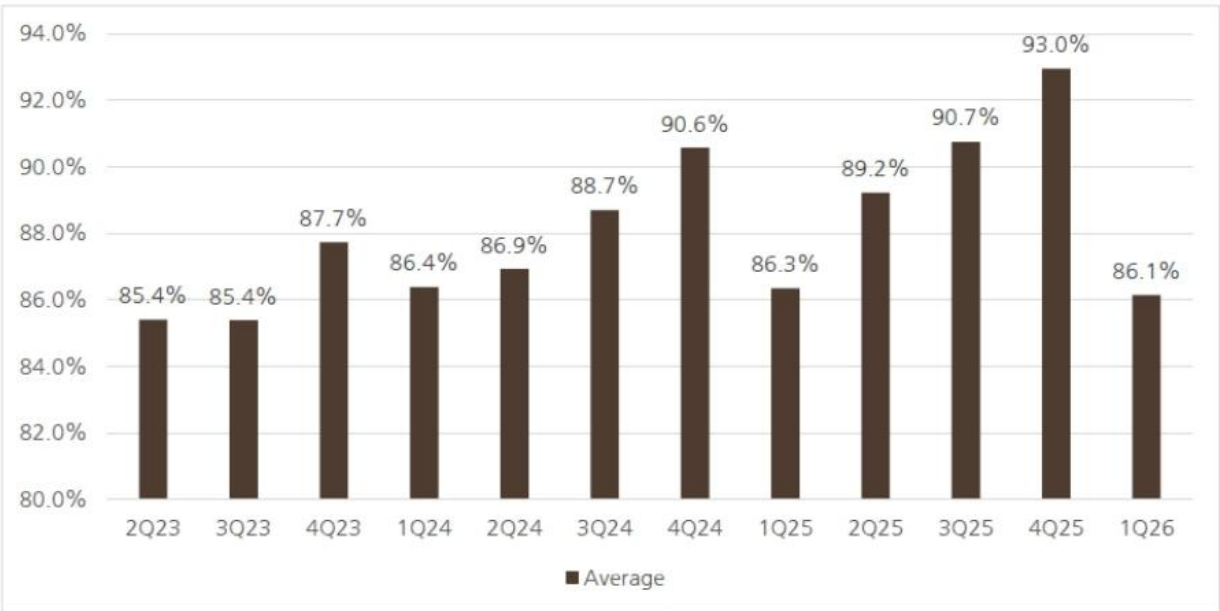
UBSHOLT评分卡是一个系统化的框架，从三个核心维度对公司进行排名：运营质量、动能和估值。这三个支柱权重相等，合并为一个总体评分卡排名，帮助读者识别有吸引力和无吸引力的公司，并且历史上与长期股东回报相关。基于HOLT的公司业绩和估值指标，HOLT评分卡提供了一套独特、差异化且易于处理的因子集。因子相对于定义的同行范围按0（最弱）到100（最强）的等级进行排名。

HOLT运营质量因子根据公司历史CFROI水平及其波动性评估其相对吸引力。HOLT动能因子衡量市场情绪，包括13周CFROI修正、价格动能和流动性。HOLT估值因子评估公司的相对吸引力，并考虑其HOLT预期上涨/下跌空间、市场隐含回报表现、宏观环境市盈率、HOLT市净率和股息回报表现。

我们纳入了描述性因子同行排名，该排名不计入总体评分卡排名，但可突出那些因其增长潜力或防御性特征而可能值得特定组合观察配置的公司。HOLT

增长因子衡量一家公司相对于同行未来现金流增长可能更高或更低的程度。HOLT 低波动因子衡量公司报价的波动性及其对区域市场变动的敏感度。为评估低波动性，该因子评估了长期月度贝塔值、长期月度价格波动率以及 90 天价格波动率。

图 12：急性后期护理同行 HOLT 评分卡与因子同行排名



图表 11

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。总体评分卡同行排名、因子同行排名和描述性因子同行排名基于区域得出。排名反映在北美地区的相对位置。公司按 HOLT 总体评分卡同行排名从左至右排列。

有关 HOLT 评分卡和因子库的更多信息，请参见此处

上图中，我们按总体评分卡排名及其基础因子组成部分对急性后期护理同行组进行了排名。该组整体表现良好，十家公司中有八家位列 HOLT 宇宙的前半部分。运营质量是最强因子，有五家公司处于前五分之一（CHE、BTSG、ADUS、EHC、SCI），这得益于高且稳定的 CFROI 水平。动量因子表现不一，而估值普遍不太有利，除 BKD 外所有公司均排名在宇宙的后半部分。

UBS HOLT Lens 中的公司分析

在本节中，我们通过 UBS HOLT Lens 分析急性后期护理同行组中每家公司的个体特征。以下分析基于 HOLT 模型默认情景，该情景基于 HOLT 的系统性衰减方法。鼓励读者在 UBS HOLT Lens 中覆盖默认情景，以反映其自身假设。

BrightSpring Health Services Inc (BTSG)

在急性后期护理同行中，BTSG 获得了最高的 HOLT 总体评分卡排名 92。自 2024 年 1 月上市以来，这家家庭和社区健康解决方案提供商的报价上涨了超过 530%。CFROI 在 2025 年升至 27% 的高点，这得益于公司通过出售其社区生活业务来合理化其经营租赁设施和许可证，从而提高了资产周转率。展望未来，CFROI 预计将在 2027 年进一步升至 32%。然而，市场似乎正在贴现回归至 2025 年的 CFROI 水平，同时伴随中个位数的增长。

图 13：UBS HOLT Lens 中的 BTSG



图表 12

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

Healthcare Services Group (HCSG)

据管理层称，HCSG 的 CFROI 在 2025 年反弹，这得益于定价改善和运营效率提升带来的利润率复苏。2026 年第一季度后强劲的报价表现和积极的 CFROI 修正支撑了其处于十分位顶部的动量因子。展望未来，CFROI 预计将保持高位，而市场定价隐含的 CFROI 约为 12%，资产增长率为高个位数。

图 14：UBS HOLT Lens 中的 HCSG



图表 13

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

Addus Homecare Corp (ADUS)

ADUS 的 CFROI 在过去五年中显著上升，这得益于利润率扩张和更高的资产周转率。值得注意的是，尽管在过去一年的大部分时间里 CFROI 修正积极，但该股在近期表现优异之前的大部分时间内落后于大盘。即使在上涨之后，该股仍低于历史估值常态交易，宏观环境市盈率为 18.2 倍，而五年中位数为 24.1 倍；HOLT 市净率为 8.9 倍，而历史中位数为 9.0 倍。尽管一致预期表明该公司将继续产生有吸引力的回报，但市场隐含的 CFROI 反映了对这些水平持久性的怀疑，当前定价表明 CFROI 长期将衰减至约 28%。

图 15：UBS HOLT Lens 中的 ADUS



图表 14

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

PACS Group Inc (PACS)

强劲的报价表现和积极的 CFROI 修正支撑了 PACS 高达 75 的 HOLT 总体评分卡排名。CFROI 在 2025 年反弹，因为利润率在人员研究（该研究在 2024 年暂时推高了销售、一般及行政费用，导致 CFROI 低于公司资本成本）之后得以恢复。CFROI 预计在未来十二个月内将进一步改善，而市场定价隐含 CFROI 水平稳定，同时资产增长率在 2030 年前保持高个位数。

图 16：UBS HOLT Lens 中的 PACS



图表 15

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

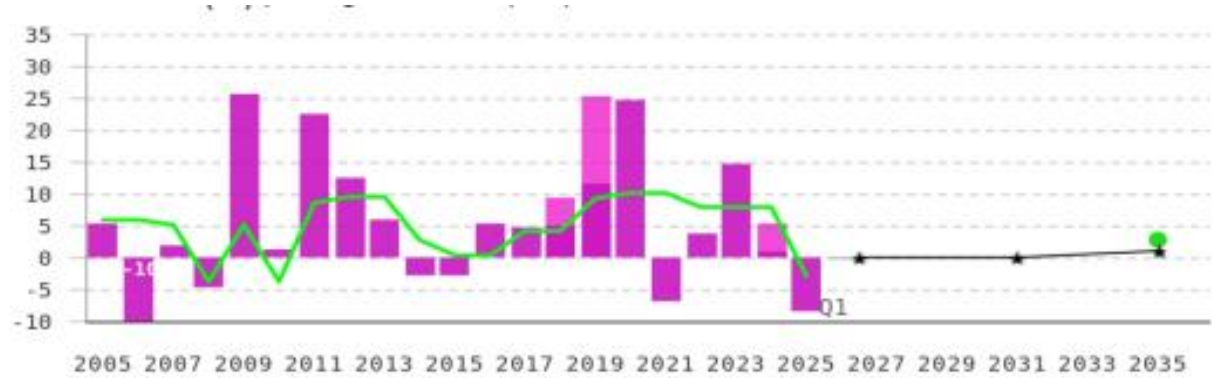
Chemed Corp (CHE)

在经历长期出现变化后，CHE 的 CFROI 预计在未来几年将有所改善，近期主要是由于其 Roto-Rooter 业务销售增长疲软和利润率不确定性所致。展望未来，公司整体 CFROI 预计将在 2027 年恢复至 32%。与此同时，CHE 的报价已从今年春季早些时候触及的多年低点反弹，市场隐含的 CFROI 表明读者预期公司将在长期内维持这些较高的近期回报水平，并伴随温和的资产增长。

图 17：UBS HOLT Lens 中的 CHE



图表 16



图表 17



图表 18

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

Encompass Health Corp (EHC)

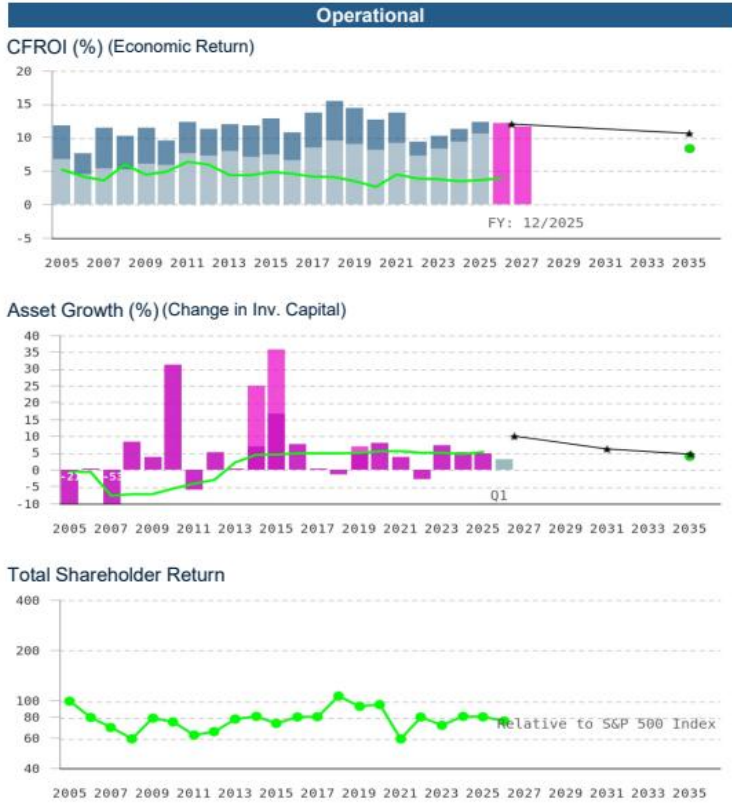
在 2022 年销售额急剧下降对资产周转率造成不确定性、导致当年 CFROI 创下十年低点之后，CFROI 近年来已出现积极拐点。同期，利润率也出现积极拐点，在 2025 年达到十年高点。尽管近期价格表现积极，但该股在绝对一年期基础上下跌，影响了 EHC 的动量因子。展望未来，CFROI 预计到 2027 年将温和下降 70 个基点，而市场定价则预期长期持续出现变化。

图 18：UBS HOLT Lens 中的 EHC

ENCOMPASS HEALTH CORP (EHC) Scenario: Model Default

Health Care Facilities

Market Cap: 10.9 USD
Scorecard Rank: 67



Valuation	
Price USD	110.16
Warranted Price	139.62
Economic PE Ratio	24.1x
HOLT Price to Book	2.9x
Dividend Yield	0.69%
Momentum	
	6m 3m 1m
CFROI Revisions	0.24 0.08 0.00
Price Change %	7.02 2.71 8.56
Company Information	
Largest Geographic Sales %	United States 100%

图表 19

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

Brookdale Senior Living Inc (BKD)

作为老年生活社区的运营商，BKD 在 HOLT 的房地产模型下进行评估。该公司历史上较低的 CFROI 水平导致其运营质量得分较低。相比之下，市场对 BKD 的情绪一直有利，强劲的价格表现和积极的 CFROI 修正推动该公司进入动量因子的第二四分位数。尽管 CFROI 预计在未来十二个月内将下降，但市场预期暗示长期将恢复至历史水平。

图 19：UBS HOLT Lens 中的 BKD



图表 20

来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

Ensign Group Inc (ENSG)

ENSG 在 HOLT 综合评分卡排名中处于第二五分位，得益于强劲的运营质量和动量因子，但相对缺乏吸引力的估值指标对其有所影响。过去五年，该公司维持了高于资本成本的稳定 CFROI 水平，同时实现了高个位数的资产增长。展望未来，一致预期指向 CFROI 持续稳定，这一观点也体现在当前市场隐含回报中，表明读者普遍预期 ENSG 将在长期内维持其现有的宏观环境盈利能力。

图 20：UBS HOLT Lens 中的 ENSG

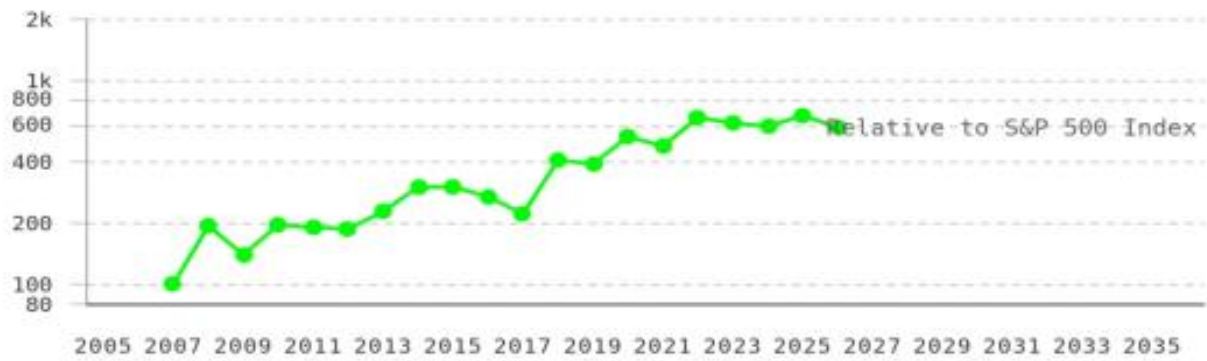
ENSIGN GROUP INC (ENSG) 情景：模型默认



图表 21



图表 22



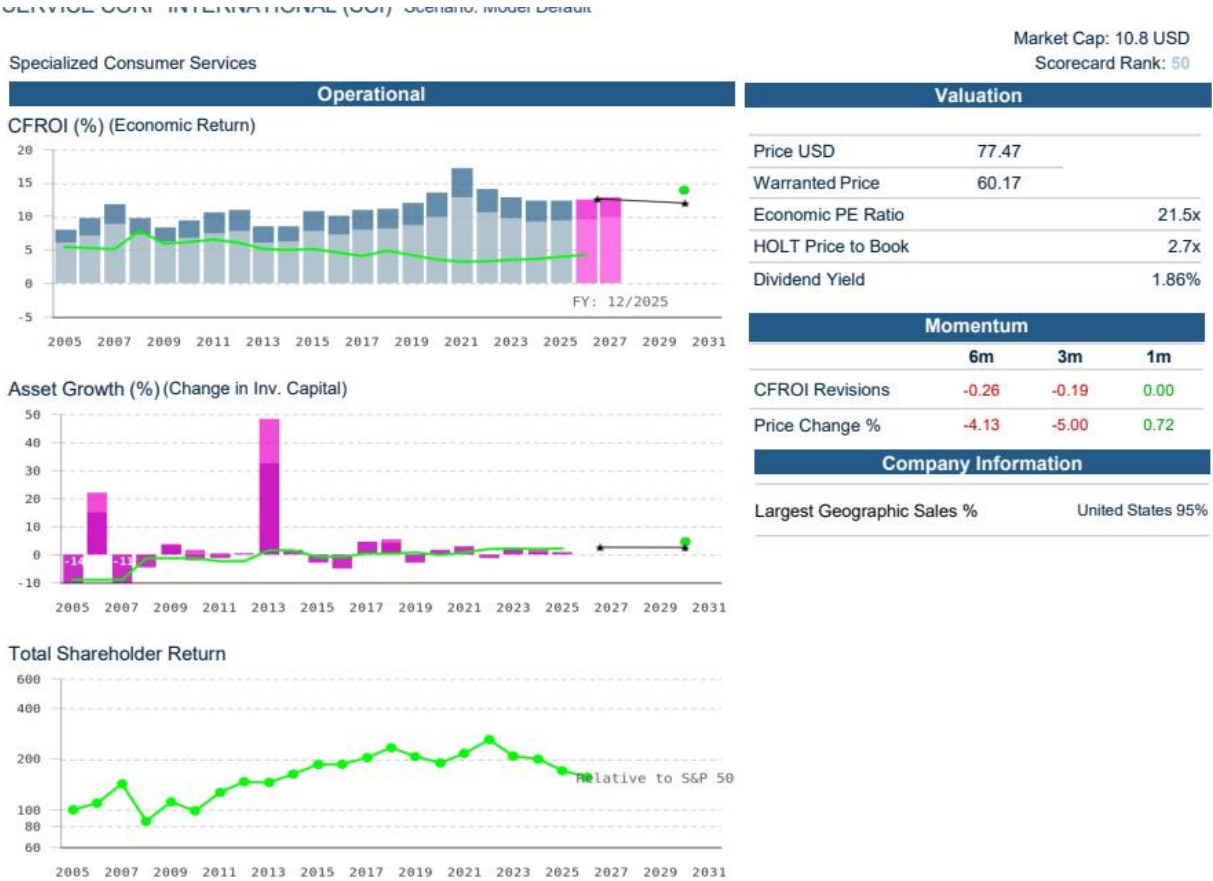
图表 23

资料来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

Service Corp International (SCI)

在 2013 年收购 Stewart Enterprises 后，SCI 的 CFROI 稳步提升，并于 2021 年因新冠疫情相关死亡率上升而达到峰值。此后 CFROI 已正常化至 12% 左右，市场定价显示其长期将逐步升至 14%。尽管运营质量强劲，但仍在调整的价格动量、谨慎的 CFROI 修正以及溢价估值影响了其整体 HOLT 评分卡排名，使 SCI 处于同业群体的下半部分。

图 21：UBS HOLT Lens 中的 SCI



图表 24

资料来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

The Pennant Group Inc (PNTG)

PNTG 于 2025 年以 1.465 亿美元收购了 UnitedHealth Group 的家庭健康和个人护理服务业务，这使其能够受益于家庭健康、临终关怀和养老运营业务的持续扩张。反映这些增长机遇，CFROI 预计将从 2025 年的 12% 升至 2027 年的 20%，而市场隐含预期则显示长期将进一步扩张至约 22%。尽管在运营质量和动量方面排名有利，但较高的市场预期和溢价 HOLT 估值倍数使 PNTG 处于估值因子的最低十分位。

图 22：UBS HOLT Lens 中的 PNTG



图表 25

资料来源：UBS HOLT Lens。数据截至 2026 年 7 月 13 日。

估值方法与不确定性声明

管理式医疗板块的不确定性包括：利用率高于预期、退保率上升以及政府监管。我。医疗服务提供商板块的不确定性包括：1) 业务量节奏变化，2) 支付方组合出现变化，3) 整合与执行问题，4) 政府监管加强，5) 运营费用高于预期，以及 6) 任何意外的宏观和监管不利发展。。

。它是一种分析工具，涉及使用一套专有定量算法和合理价值计算（统称为 HOLT 估值模型），该模型一致地应用于其数据库中包含的所有公司。HOLT 估值模型是一个现金流贴现模型。第三方数据（包括一致盈利预期）被系统地转换为多个默认变量，并纳入 HOLT 估值模型中可用的算法。由外部数据供应商提供的源财务报表、定价和盈利数据需经过质量控制，并可能进行调整以更准确地衡量公司业绩的潜在宏观环境状况。这些调整在分析单一公司跨时间变化，或分析跨行业或跨国界的多家公司时提供了可比性。

HOLT 估值模型生成的默认情景设定了一个合理价格，该价格代表基于经验推导的衰减算法所预测的标的预期均值，这些算法预测公司未来较长时间内的资本回报率和增长率。随着第三方数据的更新，合理价格会自动更新。公司未来实现的资本回报率或增长率可能与 HOLT 的默认预测不同。有关 HOLT 方法论的更多信息可应要求提供。

CFROI、CFROE、HOLT、HOLT Lens、HOLTfolio 和 “ Powered by HOLT ” 是 UBS 在美国及其他国家的商标或注册商标。HOLT 是 UBS 的一项公司绩效与估值服务。

HOLT 业务韧性仪表盘 (HBRD) 免责声明

HOLT 业务韧性仪表盘 (HBRD) 是通过对公开记录和第三方数据应用系统化流程来生成定量指标而构建的。HBRD 使用跨财务、环境和治理输入的透明指标和权重组合，一致地分配评分。单个公司可基于全球规模和/或区域规模进行相对评分。HBRD 还根据其五分位百分位排名，转化为五种文本评估（例如 “ 最高 ” 或 “ 最低 ” ）。有关 HBRD

方法论的更多详情，请参阅《HOLT 业务韧性入门》，请联系 UBS LLC，地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA，收件人：研究部。HBRD 不构成或暗示对任何个别公司的任何认可或提到。UBS 未寻求独立核实从公开和第三方来源获得的信息，并且由于公司数据报告不一致，不对此类信息的准确性、完整性或可靠性作出任何陈述或保证。此外，由于与跟踪和提供此类数据相关的全球法律、指南和法规正在演变，所有此类披露均基于非依赖基础，并可能随时更改。本报告中发布的任何数字、数值或其他数据均未按照 IOSCO 资金基准原则、EU 基准法规 (EU) 2016/1011 或任何其他基准相关监管指南的标准设计或管理，因此您不得以在这些制度（或任何全球司法管辖区的任何等效规则或法规）下构成使用资金基准的方式使用这些数字、数值或数据。HOLT 于 2024 年 10 月 1 日转让给 UBS——更名为 UBS HOLT。UBS HOLT Lens 网站和材料将逐步过渡到 UBS 品牌，预计将及时全面重新设计为 UBS 风格。